

VERTIGEM — CENTRAL vs PERIFÉRICA — VPPB

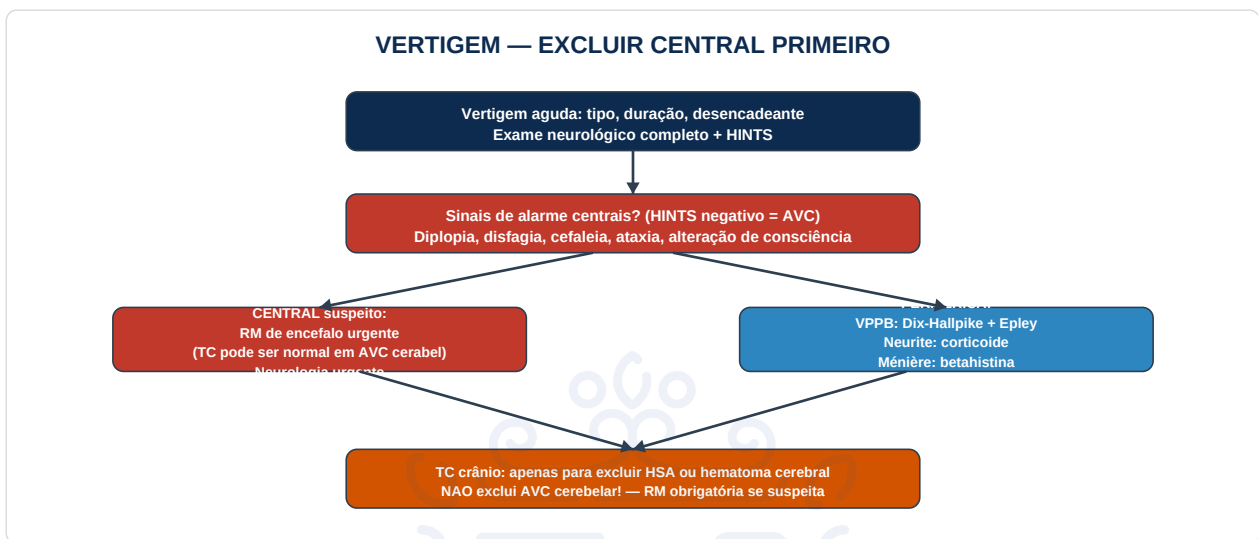
PERIFÉRICA vs CENTRAL — DIFERENCIAÇÃO

Característica	Periférica (labirinto/nervo)	Central (tronco/cerebelo)
Instalação	Brusca (segundos a minutos)	Gradual ou abrupta
Intensidade	Intensa — incapacita	Moderada — paciente consegue deambular
Náuseas/vômitos	Intensos e precoces	Menos proeminentes
Nistagmo	Horizontal com componente rotatório; inibido pela fixação visual	Vertical, puro horizontal, multidirecional; NAO inibido
Sinais neurológicos	Ausentes	Diplopia, disfagia, disartria, ataxia, paresia
HINTS (head impulse, nistagmo, test of skew)	Impulso cefálico positivo (sacada de correção)	Impulso cefálico negativo = AVC cerebelar (urgência!)
Head impulse test negativo	Periférica esperada	AVC de fossa posterior — TC/RM urgente

VPPB — DIAGNÓSTICO E MANOBRA

Aspecto	Detalhe
Definição	Vertigem desencadeada por mudança de posição da cabeça (deitar, levantar, girar no leito)
Causa	Cristais de otólito (otocônias) deslocados para canal semicircular posterior (80-85% dos casos)
Diagnóstico	Manobra de Dix-Hallpike: decúbito com cabeça em extensão 30o + rotação p/ o lado afetado — nistagmo rotatório-upbeating + latência
Duração do nistagmo	Geralmente <1 min; se nistagmo persistente ou muda de direção: suspeitar central
Tratamento	Manobra de Epley: reposicionamento dos cristais — eficácia >90% em 1-3 sessões
Recorrência	50% em 5 anos — paciente pode fazer manobra domiciliar (Brandt-Daroff)

ALGORITMO — VERTIGEM AGUDA NO PS



NEURITE VESTIBULAR — DISTINGUIR DE AVC

NEURITE VESTIBULAR (MAIS COMUM QUE AVC CEREBELAR)

- Definição: inflamação do nervo vestibular (geralmente viral — HSV1)
- Clínica: vertigem intensa de início súbito, náuseas, sem hipoacusia (sem coclear)
- Dura 3-7 dias de crise intensa, depois melhora gradual em semanas
- HINTS: impulso cefálico POSITIVO (sacada de correção visível) = periférica
- Tratamento: corticoide (prednisona 1 mg/kg x 5 dias) + dimenidrinato para sintomas
- NAO confundir com AVC cerebelar: impulso cefálico NEGATIVO = central

MENIERE E TRATAMENTO SINTOMÁTICO

Síndrome de Mênière

- Tríade: vertigem episódica (20 min-12h) + hipoacusia flutuante + zumbido
- Fisiopatologia: hidropsia endolinfática (acúmulo de endolinfa)
- Audiometria: perda neurosensorial em frequências GRAVES (diferente de PANSS)
- Diagnóstico: clínico — Dix-Hallpike negativo; sem sinais centrais
- Tratamento: betahistina 16-48 mg/d, diuréticos, dieta hipossódica
- Refratário: injeção intratimpânica de gentamicina ou cirurgia (labintectomia)

Antivertiginosos no PS

- Dimenidrinato (Dramin) 50 mg IV/IM/VO: 1a escolha no PS para controle sintomático
- Ondansetrona 4-8 mg IV: para náuseas refratárias
- Benzodiazepínico (diazepam 5 mg VO): vertigem central com agitação
- NAO usar antivertiginosos cronicamente (inibem reabilitação vestibular central)
- Evitar em idosos: risco de quedas e confusão mental

MANOBRA DE EPLEY — PASSO A PASSO

VPPB CANAL POSTERIOR

- ☐ Posição 1: sentado, cabeça girada 45º para o lado afetado (Dix-Hallpike positivo)
- ☐ Posição 2: deitar com a cabeça no mesmo angulo (30º pendente fora da maca) — aguardar 30s-1 min
- ☐ Posição 3: girar cabeça 90º para o lado oposto — aguardar 30s-1 min
- ☐ Posição 4: girar corpo junto com a cabeça — olhar para baixo (45º) — aguardar 30s
- ☐ Posição 5: sentar lentamente — cabeça voltando ao neutro
- ☐ Resultado: 80-90% de melhora na 1a sessão; repetir em 2 semanas se necessário

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Mulher de 45 anos com vertigem ao deitar e ao se levantar. Dix-Hallpike positivo à direita com nistagmo rotatório com latência de 5s e duração de 30s. Diagnóstico e conduta?

- A) AVC cerebelar — RM urgente
- B) Neurite vestibular — corticoide IV
- C) VPPB canal posterior direito — manobra de Epley
- D) Síndrome de Ménière — betahistina
- E) Labirintite aguda — dimenidrinato IV e internação

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado no exame HINTS indica origem CENTRAL da vertigem aguda?

- A) Impulso cefálico positivo (sacada de correção visível)
- B) Nistagmo horizontal com componente rotatório inibido pela fixação visual
- C) Head impulse test negativo (sem sacada de correção) associado a nistagmo
- D) Tinnitus unilateral associado à vertigem
- E) Náuseas e vômitos intensos

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a TC de crânio NAO exclui AVC de fossa posterior em paciente com vertigem aguda?

- A) Porque a TC sempre é normal em neurologia
- B) Porque a fossa posterior tem muitos artefatos ósseos na TC — RM é obrigatória para AVC cerebelar
- C) Porque AVC cerebelar só aparece em 48h
- D) Porque a TC usa contraste nefrotóxico
- E) Porque TC é suficiente se o exame neurológico for normal

QUESTÃO 4

SES-GO / Adaptada

Neurite vestibular difere da síndrome de Ménière porque:

- A) Neurite tem zumbido e hipoacusia, enquanto Ménière é apenas vertigem isolada
- B) Neurite causa vertigem contínua SEM hipoacusia, enquanto Ménière tem tríade (vertigem + hipoacusia + zumbido) em episódios
- C) Neurite é tratada com betahistina, enquanto Ménière usa corticoide
- D) Neurite é de origem central, enquanto Ménière é periférica
- E) Neurite tem Dix-Hallpike positivo, enquanto Ménière é negativo

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é o objetivo da manobra de Epley no VPPB?

- A) Inibir os canais semicirculares por compressão
- B) Reposicionar as otocônias deslocadas de volta ao utrículo, cessando o estímulo anômalo
- C) Reduzir a pressão endolinfática
- D) Fortalecer a musculatura vestibular compensatória
- E) Estimular o sistema nervoso central a compensar o desequilíbrio

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Dix-Hallpike positivo: nistagmo rotatório-upbeating com latência de 5-20s e duração <1 min = VPPB canal posterior. Tratamento: manobra de Epley (reposicionamento das otocônias). Eficácia >90% em 1-3 sessões. Não indica exames de imagem de urgência se HINTS periférico.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

HINTS test: Head impulse + Nystagmus + Test of skew. Impulso cefálico NEGATIVO (sem sacada de correção) em paciente com vertigem aguda = sinal de alarme para causa CENTRAL (AVC cerebelar). Maior sensibilidade para AVC que RM nas primeiras 24h! Impulso positivo = periférica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

TC de crânio tem muitos artefatos na fossa posterior (osso temporal, base do crânio) — sensibilidade de apenas 16-20% para AVC cerebelar nas primeiras 24h. RM de encéfalo (DWI) tem sensibilidade >95%. Se HINTS negativo (central): RM urgente, mesmo com TC normal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Neurite vestibular: vertigem intensa contínua (dias) + náuseas, SEM hipoacusia nem zumbido (nervo coclear preservado). Ménière: tríade episódica (vertigem + hipoacusia flutuante + zumbido). Distinção importante: hipoacusia = coclear envolvido = Ménière ou PANSS associada.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

VPPB: otocônias (cristais de carbonato de cálcio) se desprendem do utrículo e migram para canal semicircular posterior. Estímulo gravitacional anômalo = vertigem posicional. Manobra de Epley: rotações sequenciais da cabeça para guiar cristais de volta ao utrículo. Sem cristais no canal = sem vertigem.

SM24
Suporte ao Plantão Médico